



Distúrbio do Sono nos Idosos

Introdução

Segundo a OMS, cerca de 40% dos brasileiros e 45% da população mundial apresenta dificuldade para dormir, sendo maior ainda em idosos.

Mais comum em pacientes do sexo **feminino** e que possuam **comorbidades neuropsiquiátricas**. Quadros demenciais e declínios cognitivos podem ter alguma associação também.

Sono é importante para memória, termorregulação, conservação e restauração do metabolismo energético cerebral. Por isso, o sono insuficiente na população em geral pode ocasionar:

- Déficit cognitivo;
- Alterações do humor;
- HAS;
- Aumento da resistência insulínica e DM2;
- Redução da imunidade: aumento de quadro gripais e de IVAS;
- Aumento do risco de neoplasia de mama;
- Diminuição do limiar a dor: piorando quadros álgicos.

Sono insuficiente no idoso pode comprometer:

- Atenção: principalmente;
- Capacidade de planejamento e tomada de decisões;
- Risco aumentado de quedas;
- Institucionalização;
- Baixa qualidade de vida;

- Aumento da mortalidade: geral, por qualquer causa.

Fisiologia do sono

O sono é um estado funcional, reversível e cíclico. Consiste em uma resposta fisiológica regulada homeostaticamente, produzida e controlada pelo núcleo supraquiasmático hipotalâmico.

Envolve diversos núcleos, sendo os mais importantes:

- **Núcleo supraquiasmático hipotalâmico:** melatonina. Os idosos tem a melatonina reduzida fisiologicamente;

Ligações com diversos outros sistemas hipotalâmicos pelo gaba, histamina, serotonina, acetilcolina. Por isso muitos medicamentos podem afetar a qualidade do sono.

- **Atividade do Sistema Glinfático:** sono REEM, importante para a nutrição e limpeza cerebral;

A ativação do sistema glinfático está relacionada não só com a limpeza cerebral pela eliminação das neurotoxinas produzidas durante o período da vigília, como também com o fornecimento de nutrientes para os tecido

A interrupção do sistema glinfático ocasiona falha na depuração de solutos presentes nos fluidos intersticiais, o que pode ter relevância clínica em doenças neurodegenerativas, nas quais o acúmulo de substâncias neurotóxicas contribui com a sua evolução.

Tempo de sono:

- Adulto 6,5 a 8,5 horas por noite;
- Idoso 5 a 7 horas por noite. Pela própria redução da melatonina e outras alterações. "Antes eu dormia até as 9 horas, hoje durmo até as 7 horas", é comum, e é normal.

Dormir mais não quer dizer que tem problema, mas devemos fazer a avaliação subjetiva.

▼ Arquitetura normal do sono

▼ Sono NREM

Sincronizado com o córtex, aumento do tônus parassimpático, redução da temperatura corporal, redução da PA, da FC e do ritmo respiratório.

Dividido em N1, N2, e SWS (sono de ondas lentas, correspondendo ao N3 e N4).

- **Estágio N1 (Transição/Sono Leve):** Dura de 5 a 15 minutos. É o início do adormecimento, com relaxamento muscular, respiração lenta e desconexão fácil com o ambiente.
- **Estágio N2 (Sono Leve/Moderado):** Constitui cerca de 50% do total do sono. A temperatura do corpo cai, os batimentos cardíacos e a respiração diminuem. É uma fase de desconexão maior com o ambiente, preparando para o sono profundo.
- **Estágio N3 e N4 (Sono Profundo):** Também conhecido como sono de ondas lentas ou "Delta". É o estágio mais restaurador, crucial para a recuperação física, fortalecimento do sistema imunológico e liberação de hormônios como o do crescimento (GH).

Mais presentes na primeira metade da noite. Na segunda metade prevalece o sono REM.

Obs: em casos de apneia do sono e na hipertensão não há a hipotensão noturna.

▼ Sono REM

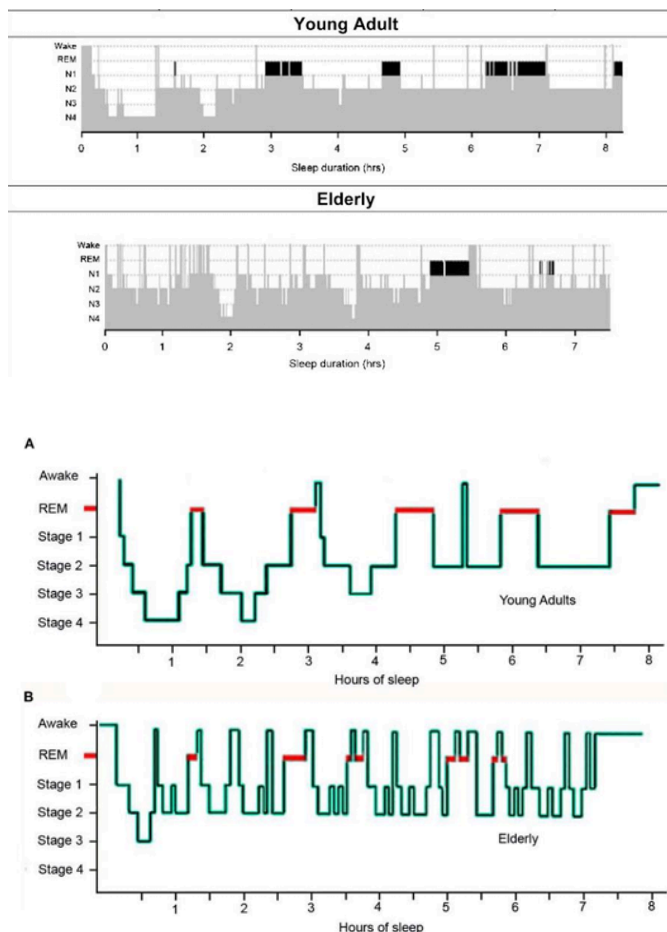
Movimentos rápidos dos olhos, desconexão/dessincronizado com o córtex.

Ocorre cerca de 90 minutos após o início do sono, e é mais comum a partir das 3 horas da manhã.

Com redução do tônus muscular mais importante, possível ser percebida na polissonografia, diminuição da PA e da FC. Ocorre sonhos, fixação do aprendizado e limpeza pelo sistema linfático.

Uma alteração nessa fase causa muitos problemas cognitivos.

Obs: WASO são despertares noturnos, sendo que esses aumentam com o a idade.



O sono REEM reduz com o envelhecimento, é um paciente que demora a dormir, tem um sono mais leve, tem mais despertares ao longo da noite.

Obs: esses despertares não quer dizer que o paciente acorda, retoma consciência, apenas quer dizer que o cérebro voltou a fazer conexões como se estivesse acordado.

Diagnóstico

Sempre considerar uma síndrome geriátrica, pois as causas costumam ser multifatoriais.

Queixas clínicas:

- Insônia de manutenção: paciente dorme 23h, acorde 00h, dorme de novo, são despertares diversos;
- Insônia inicial: demora para começar a dormir, mas dorme a noite toda;

- Sonolência diurna: geralmente relacionada a má qualidade de sono;
- Sono não reparador: paciente dorme o tempo adequado mas ao despertar tem a sensação que não dormiu nada;
- Outros sintomas inespecíficos: pode ser por medicações, demência.

DSM-5 define distúrbio do sono como algo que cause insatisfação quanto à qualidade ou quantidade de sono, por 3 noites/semana por pelo menos 3 meses.

CID-11 já indica distúrbio de sono por UM mês de sintomas não explicadas por outro distúrbio do sono, uso de substâncias ilícitas e/ou distúrbios médicos e psiquiátricos coexistentes.

Avaliação do sono:

- | | |
|--------------------------------------|--|
| • Horário de deitar; | • Horário que levanta-se da cama pela manhã; |
| • Quantidade/duração de despertares; | • Cochilos diurnos; |
| • Latência até dormir; | • Sintomas diurnos (fadiga, dificuldade de concentração...). |

Investigar SAOS (apneia do sono) pela presença de sintomas matutinos como cefaleia, boca seca (dorme de boca aberta, ronca), congestão nasal, cansaço, sonolência diurna excessiva.

Também devemos investigar medicações (B-bloqueador pode induzir pesadelo se tomado a noite) e doenças que possam alterar o sono. Por exemplo, Parkinson que pode causar distúrbio de sono REEM.

Substância	Provável efeito
Etanol	Apesar de ter um efeito indutor do sono, promove sua fragmentação durante a noite
Anticolinérgicos	Insônia e pesadelos durante a noite
Betabloqueadores	Alteração da fisiologia do sono com manifestação de pesadelos em alguns casos
Xantinas e fenilefedrinas	Efeito estimulante; dar preferência ao uso longe do horário de dormir
Levodopa	Insônia e pesadelos
Corticosteroides sistêmicos e inalatórios	Efeito estimulante e agitação psicomotora durante a noite; dose-dependente
Diuréticos e bloqueadores do canal de cálcio	Nictúria. Evitar o uso próximo à hora de dormir
Nicotina	Insônia; desestimular uso e/ou evitar durante a noite
Fenitoína	Insônia
Teofilina	Efeito estimulante (substituir por um broncodilatador dosimetrado ou outra opção terapêutica)
Antidepressivos inibidores da recaptação de serotonina e antidepressivos duais	Insônia inicial ou terminal

▼ Ferramentas auxiliares diagnósticas

- **Diário do sono-vigília**

Avaliação por 2 semanas e registro do sono, horário que deita, que adormece, que levanta, quantificar despertares, registrar atividade física, uso de álcool e medicações.

- **Insomnia Severity Index/Pittsburgh Sleep Quality index:**

Avalia as mesmas questões anteriores mas acrescenta a avaliação da qualidade do sono reparador, satisfação. "tive esses sintomas e acho que meu sono foi bom/ruim nesse dia".

- **Actigrafia:** equipamento que registra os movimentos do paciente, informações sobre sono e vigília;

- **Polissonografia (PSG):** principal exame

Método diagnóstico que faz o registro simultâneo de algumas variáveis fisiológicas (neurofisiológicas, cardiorrespiratórias, entre outras) durante o período principal de sono. Consiste em um exame de noite inteira, realizado em um laboratório especializado, sob supervisão contínua de um técnico habilitado em PSG.

Aferição de variáveis fisiológicas por meio do EEG, eletro-oculograma, eletromiograma, ECG, fluxo aéreo (nasal e oral), transdutor de pressão nasal, esforço respiratório (torácico e abdominal), SpO2, ronco, posição corporal. Mas há algumas mais simples, mais indicadas em apneia.

As informações são coletadas por sensores espalhados pelo corpo que medem e analisam seus resultados, os quais devem ser correlacionados com a história clínica

Mais indicada em **transtornos respiratórios do sono, avaliação/titulação de CPAP** (avaliar as apneias e hipopneias).

A PSG, apesar de ser um instrumento importante de avaliação de distúrbios do sono, **não faz diagnóstico de insônia**, mas pode ser útil em algumas circunstâncias, como na suspeita de sua associação com distúrbios respiratórios do sono e para avaliação objetiva do padrão de sono, podendo verificar também o grau de má percepção do sono.

Sempre antes de iniciar a investigação ou um tratamento, verificar se o paciente segue medidas de higiene de sono

■ **TABELA 24.1** Orientações sobre higiene do sono.

1. Dormir o suficiente*
2. Ter regularidade nos horários de deitar e levantar, inclusive nos finais de semana
3. Não forçar o sono
4. Evitar uso de estimulantes como cafeína, nicotina ou álcool no período da tarde e da noite
5. Não dormir com fome
6. Deixar o ambiente aconchegante (luz, temperatura e ruído)
7. Não levar problemas e preocupações para a cama
8. Manter rotina de exercícios físicos, no máximo até 3 h antes de deitar para dormir
9. Massagem, música suave, banho morno, aquecimento dos pés
10. Dar prioridade para ingestão de alimentos leves e/ou ricos em triptofano (ingestão de leite morno com maçã) e bebidas mornas, exceto café, chás e chocolate, que são estimulantes
11. Estar atento ao conforto do local onde se está dormindo (tipo de colchão, travesseiro, lençol macio)
12. Manter o celular desligado ou no silencioso durante a noite
13. Desencorajar o uso de nicotina e, na impossibilidade de retirá-la, tentar reduzi-la e evitar uso à noite
14. Usar roupas confortáveis para dormir
15. Evitar luminosidade próximo à cama durante a noite
16. Evitar cochilos prolongados, acima de 45 min, sobretudo a partir das 15 h
17. Evitar assistir à TV na cama, antes de dormir, e evitar ingerir alimentos próximo ao horário de dormir
18. Evitar ficar muito tempo na frente do computador próximo ao horário de dormir

Principais alterações no sono do Idoso

- Insônia;

- Síndrome das Pernas Inquietas;
- Movimentos periódicos dos membros;
- Transtorno comportamental do sono REM (TCSR ou DCSREM);
- Transtornos do ritmo circadiano;
- Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono (SAOS);
- Síndrome da Apneia Obstrutiva do sono de causa Central;
- Outros distúrbios do sono: roncos e sonolência diurna excessiva.

▼ Insônia

▼ Definição

Dificuldade para iniciar ou manter o sono que está associada a consequências diurnas (sonolência excessiva) e não é atribuível a circunstâncias ambientais ou a oportunidade inadequada de dormir (plantão por exemplo).

▼ Epidemiologia

30 a 40% dos idosos possuem queixas de insônia.

Mais comum no sexo feminino, baixa escolaridade, renda insuficiente, depressão, TAG, dor crônica, câncer, DPOC, DCV e uso de medicamentos (maior uso de medicamentos maior risco de algum interferir no sono).

Maior prevalência da insônia de manutenção e não inicial.

▼ Diagnóstico

É **clínico pela avaliação do sono**, se conseguir fazer o diário é muito bom, mas se não for possível fazer anamnese bem detalhada.

Analisar medicações em uso ou cessadas que possam estar relacionadas temporalmente, analisar também cafeína, álcool e nicotina.

Obs: não damos diurético a noite para o idoso porque ele pode levantar para urinar, e isso aumenta o risco de queda e fratura de fêmur.

Investigar comorbidades como transtornos neuropsiquiátrico, e como está a higiene do sono. Acredita-se que transtornos neurológicos, enxaqueca, dor crônica, distúrbios endócrinos (hipotireoidismo/ hipertireoidismo),

DPOC, asma, refluxo gastroesofágico e insuficiência cardíaca congestiva podem causar ou agravar a insônia.

Pode-se utilizar ferramentas diagnósticas se necessário.

▼ Tratamento

▼ 1ª linha

Medidas não farmacológicas:

- **Higiene do sono:** evitar sonecas diurnas, manter um horário regular para dormir, limitar uso de substâncias estimulantes como bebidas com cafeína, nicotina e álcool, que afetam adversamente o sono, e exercitar-se pelo menos 3 horas antes de dormir;
- **Técnicas de relaxamento;**
- **Terapia de restrição do sono:** envolve restringir o tempo na cama ao número de horas de sono real, até que a eficiência do sono melhore. Por exemplo, paciente vai dormir 19h e acorda 2h, a resolução possivelmente seria dormir mais tarde;
- **Terapia de controle de estímulos:** busca associar o uso da cama com a hora de dormir. Isso inclui ir para a cama apenas quando se sente cansado; e não usá-la para ler, trabalhar ou descansar;
- **Terapia cognitivo-comportamental para insônia (TCC-I);**

Obs: algumas terapias direcionadas a insônia podem ter a mesma eficácia dos benzodiazepínicos.

Envolve a terapia de restrição do sono, terapia de controle de estímulos, higiene do sono e terapia cognitiva.

- Terapia breve comportamental para insônia.

▼ Farmacológico

Sempre ajustar às expectativas do paciente, alinhar objetivos, avaliar perfil de segurança das medicações, efeitos colaterais, interações medicamentosas, custo, comorbidades, contraindicações.

▼ Benzodiazepínicos e compostos Z

Ligação aos receptores GABA, reduzindo a excitabilidade. Mais indicado para quadros agudos.

Podemos usar apenas por **pouco tempo**, sendo muito bem avaliado o risco-benefício, pois no geral ele será contraindicado.

Curto prazo causa:

- Aumento do tempo total do sono e da qualidade do sono (paciente refere que o sono está melhor);
- Diminuição da latência para início do sono e o número de despertares noturnos;
- Aumento do sono N2 e diminuição do N1 e REM (por reduzir o REM pode causar distúrbios cognitivos, paciente pode referir estar mais esquecido depois do uso).

Longo prazo pode causar resistência, dependência (difícil de ser contida), insônia rebote, sedação residual durante o dia (por ser lipofílico pode ter efeito prolongado), ausência de coordenação motora, comprometimento cognitivo e aumento do risco de queda.

Exemplo: Clonazepam, Alprazolam, Diazepam.

Benefício no sono é igual ou inferior ao TCC-I.

Obs: piora a apneia do sono em pacientes que tem essa patologia, da mesma forma que o álcool, pois por relaxar mais, tem mais queda de glote, piora saturação.

Compsotos Z como Zolpidem, é comum ter muito efeito colateral como esquecimento, tontura. O mecanismo de ação é semelhante aos benzodiazepínicos. Mas não prescrevemos.

▼ Antidepressivo sedativo

- **Doxepina (2-6 mg)**: tricíclico, antagonista receptores H1;

Melhora vários parâmetros, com poucos efeitos colaterais, mais recomendado na **insônia de manutenção** pois aumenta o tempo total de sono, sem afetar sono REEM, sono profundo e sono leve.

Não utilizamos em doses antidepressivas, geralmente é 2-6 mg manipulado (não vende em farmácia).

- **Mirtazapina (7,5-15 mg):**

Ótima escolha para pacientes com **Neoplasias** pois é antidepressivo, orexígeno (aumenta a fome), sedativo.

Mas, em virtude da habituação de seus efeitos sedativos de evidências, não é recomendada para insônia na ausência de depressão. Pode potencializar efeitos da Sertralina, por exemplo.

- **Trazodona (25-50 mg):**

Indicado para **insônia inicial ou manutenção**, sendo mais indicada quando distúrbios cognitivos presentes. Reduz a latência do sono.

Efeitos colaterais importantes: tontura, arritmia, hipotensão, priapismo (por agir no sistema alfa-adrenérgico). Mas são mais comuns em doses altas, não tendo tanto efeito nas doses sedativas.

- **Quetiapina (25-50 mg):**

Nunca primeira escolha, vários efeitos colaterais, incluindo aumento de mortalidade em pacientes com demência.

Se utilizado, deve ser com cautela e individualizado.

▼ **Antagonistas de receptores de hipocretina (orexina)**

Aumento do sono REM e maior efeito na manutenção. Poucos efeitos colaterais, apenas sonolência matutina.

Custo elevado.

Exemplo: Suvorexanto.

▼ **Anticonvulsivantes**

Pregabalina e Gabapentina são muito úteis em pacientes com dor crônica.

Útil para síndrome das pernas inquietas, transtorno dos movimentos periódicos dos membros inferiores.

Pode causar tonturas, desmaios.

▼ **Melatonina e análogos**

- **Melatonina.**

Há declínio da produção de melatonina em pacientes > 55 anos.

Tem ação facilitadora, mas necessita higiene do sono para ter algum efeito.

- **Ramelteona:** análogo da melatonina.

Utilizada mais para insônia inicial, diminui N1 e aumenta os demais, com poucos efeitos colaterais.

▼ **Síndrome das pernas inquietas/Síndrome de Ekbon**

▼ **Epidemiologia**

Mais na população acima de 65 anos (pico de incidência entre 85-90 anos) e mais prevalente na população feminina, com grande componente familiar.

85% associada a Movimentos Periódicos dos Membros (MPM).

Associação com Parkinson (inclusive o tratamento é com medicamento anti-parkinsoniano), DM, AR, gestação, tabagismo, álcool, cafeína, medicações (anti-histamínicos e antidepressivos).

Investigar deficiência de ferro, neuropatia periférica, insuficiência renal.

▼ **Diagnóstico**

É clínico e inclui os seguintes aspectos fundamentais:

1. Urgência em movimentar os membros, associada a parestesias e disestesias;
2. Sintomas que se iniciam ou pioram com o repouso;
3. Melhora parcial dos sintomas com o movimento;
4. Piora dos sintomas no final da tarde ou à noite;

5. Não podem ser bem explicados por uma outra condição médica.

▼ Tratamento

Medidas não farmacológicas como terapia cognitivo-comportamental, relaxamento, atividade física.

Farmacológico:

- 1ª linha: Pramipexol em doses baixas (0,25 mg já é muito útil);
- 2ª linha: Ropirinol, Levodopa, Gabapentina ou Pregabalina.

▼ Movimentos periódicos dos membros (MPM)

▼ Definição

Episódios repetitivos de movimentos estereotipados, involuntários e recorrentes dos membros inferiores com duração de 0,5 a 10 segundos e que ocorrem mais na primeira metade da noite.

▼ Epidemiologia

Prevalência maior com maior idade, mais na população branca. Acomete ambos os sexos na mesma proporção.

▼ Diagnóstico

É de exclusão, sendo preciso a polissonografia.

A PSG vai realizar mensuração da atividade do musculo tibial, sendo normal <15/hora.

▼ Tratamento

Tratamento quando necessário é o mesmo da SPI.

▼ Transtorno comportamental do sono REEM (TCSR ou DCSREM)

▼ Definição

É uma parassonia caracterizada pela perda da atonia muscular normal durante o sono REM, com aumento do tônus mentoniano e da atividade motora dos membros inferiores. Havendo atividade motora proeminente durante o sonho, paciente tenta "agir fora dos sonhos".

Quando há pesadelos, estes geralmente são de conteúdos relacionados com pessoas e animais, exteriorizados por comportamentos violentos e

algumas vezes com agressividade feitos contra o próprio paciente ou contra o seu parceiro de leito.

▼ Epidemiologia

Mais presente na população masculina (9:1) acima de 60 anos.

Associação com doenças neurodegenerativas como:

- **Alfa-sinucleinopatias:** na grande maioria dos casos;
 - Doença de Parkinson: pode ser um sinal precoce antes dos tremores;
 - Demência por corpos de Lewy.
- **Não Alfa-sinucleinopatias:**
 - Paralisia supranuclear progressiva, demência Fronto temporal, esclerose lateral amiotrófica, Alzheimer, doença de Huntington;
 - Lesões pontinas;
 - Narcolepsia;
 - Antidepressivos;
 - Abstinência a álcool, benzodiazepínicos, inibidores da MAO e barbitúricos

▼ Diagnóstico

É clínico, corroborado pela PSG.

Os sintomas são de movimentos complexos, vocalização durante o sono. O paciente não recorda o que fez geralmente lembra do sonho.

Queixa mais comumente trazida pelo companheiro.

Na PSG, os achados polissonográficos incluem tônus muscular excessivo no queixo e movimentos de perna durante o sono REM.

▼ Tratamento

Objetivo de diminuir a frequência e a gravidade dos comportamentos e diminuir os sonhos desagradáveis.

Medicamentos:

- Clonazepam 0,25 a 0,5mg. Em pacientes sem comprometimento cognitivo sem SAOS;

Obs: é inadequado para idosos mas é a medicação que mais resolve.

- Melatonina 3-12mg, podemos fazer o teste antes de começar o Clonazepam;
- Outras opções: pramipexol, levodopa, carbamazepina, clozapina e quetiapina.

▼ Transtornos do ritmo circadiano

▼ Definição

Dentre os distúrbios do ritmo circadiano, os mais encontrados na população idosa são: o distúrbio de atraso de fase, o distúrbio de avanço de fase, do ciclo sono-vigília/sono irregular, o distúrbio de ritmo não 24 horas, o jet-lag.

Obs: jet-lag é quando há uma dessincronização do ciclo circadiano em pessoas quando fazem viagens transmeridianas. Em geral, ocorre um mal-estar relacionado com uma sensação de “descompasso”, associados à fadiga durante todo o dia, dificuldade para dormir à noite e desempenho mental diminuído.

Podemos dividir as pessoas em matutinas, vespertinas ou indiferentes:

- Matutinas (10 a 12% da população) são aquelas que dormem cedo e que acordam cedo, já dispostas para desempenhar suas atividades diárias. As fases endógenas dessa categoria da população costumam estar adiantadas em relação à população em geral;
- Vespertinos (8 a 10% da população) são aqueles que dormem tarde e acordam tarde, em especial nas férias e nos finais de semana, dando preferência a desempenhar suas atividades à tarde ou à noite. Os picos máximos de seus ritmos circadianos estão atrasados em relação aos da população em geral;
- Indiferentes são aqueles que não têm horários preferenciais para dormir e acordar.

No avanço de fase do ciclo sono-vigília, o paciente adormece mais cedo (entre 19 e 20 horas), acorda entre 3 e 4 horas da madrugada e demonstra sonolência diurna com cochilos longos.

A luz é o mais importante sincronizador do ritmo circadiano, daí a importância de estimular o idoso a se expor ao sol durante a manhã.

▼ Tratamento

Indicamos exposição solar e melatonina.

▼ Síndrome da apnia obstrutiva do sono

▼ Definição

Episódios recorrentes de obstrução parcial (hipopneia) ou total (apneia) da via aérea superior durante o sono.

É identificada por redução ou ausência de fluxo aéreo, apesar da manutenção dos esforços respiratórios, geralmente resultando em dessaturação da oxi hemoglobina e despertares noturnos frequentes, com consequente sonolência excessiva durante o dia.

▼ Epidemiologia

25% dos homens, 11% das mulheres >40 anos.

▼ Fisiopatologia

Alteração da musculatura anatômica na faringe com aumento do colapso das vias aéreas superiores, sendo relacionado a idade.

▼ Fatores de risco

Homem, obesidade, circunferência do pescoço >40cm, alterações faciais.

Agravantes são tabagismo, etilismo, DRGE e hipotireoidismo.

A SAOS é reconhecida como um fator de risco independente para várias patologias cardiovasculares, como: hipertensão arterial, instalação e piora de arritmias, AVE e síndrome coronariana.

▼ Diagnóstico

É clínico, mas a polissonografia é o padrão-ouro.

Paciente refere:

- Despertar noturno com a boca aberta ou dor de garganta;
- Despertar com sensação de sufocamento;
- Episódios de parada respiratória durante o sono intercalados com ronco;
- Mau humor;
- Cefaleia matinal;
- Falta de concentração.

Na AOS, os microdespertares levam a ativação simpática, causando perda do descenso noturno e HAS. Há ainda a HAP secundária, principalmente a hipóxia intermitente com contribuição da hipercapnia.

Podemos realizar o **questionário de STOP BAND**:

- ≥3 respostas positivas → alto risco para apneia;
- <3 respostas positivas → baixo risco para apneia.

Questionário STOP BANG

1- **S** (Ronco): Você ronca alto (mais alto do que falar ou alto o suficiente para o ronco ser ouvido mesmo de portas fechadas)?

Sim () Não ()

2- **T** (Cansaço) Você frequentemente sente-se cansado, com fadiga ou sonolência durante o dia?

Sim () Não ()

3- **O** (Observação de apneia): Alguém observou se você teve parada respiratória durante o sono?

Sim () Não ()

4- **P** (Pressão): Você é hipertenso ou está fazendo tratamento para hipertensão?

Sim () Não ()

5- **B** (Índice de massa corpórea - IMC): IMC maior que 35 kg/m²?

Sim () Não ()

6- **A** (Idade): Idade maior que 50 anos?

Sim () Não ()

7- **N** (Circunferência do pescoço): circunferência do pescoço maior que 40 cm?

Sim () Não ()

8- **G** (gênero): gênero masculino?

Sim () Não ()

Três ou mais respostas positivas: **Alto risco** para apneia obstrutiva do sono

Menos que três respostas positivas: **Baixo risco** para apneia obstrutiva do sono.

Na PSG é possível notar um decréscimo >50% na amplitude da respiração durante 10 segundos.

Sua gravidade é classificada de acordo com o Índice apneia-hipopnéia (IAH) por hora de sono:

- Normal: até 5 eventos/h;
- Leve: 6-15 eventos/h;
- Moderado: 16-30 eventos/h;
- Grave: >30 eventos/h.

▼ Tratamento

Medidas não-farmacológicas são decúbito lateral, diminuir os fatores de risco/agravamento como perda ponderal, atividade física, álcool, cigarro, evitar sedativos.

Mas o **tratamento de primeira linha e mais efetivo da SAOS, em qualquer faixa etária, é a administração de pressão positiva nas vias respiratórias.**

CPAP é o mais efetivo em qualquer gravidade para eliminar os episódios de apneia, hipopneia, roncos. Deve manter SpO2 >90%.

Casos leves pode-se usar aparelhos intraorais mas tem limitação em idosos edentados.

IAH	Sintomas	Doença cardiovascular	Recomendações
5 a 30	Sim	Sim	Possibilidade de uso de CPAP
5 a 30	Sim	Não	Possibilidade de uso de CPAP
5 a 30	Não	Sim	Possibilidade de uso de CPAP
5 a 30	Não	Não	Medidas não farmacológicas
> 30	Sim	Sim	O uso de CPAP é obrigatório
> 30	Sim	Não	O uso de CPAP é obrigatório
> 30	Não	Sim	CPAP
> 30	Não	Não	Considerar o uso de CPAP

Quanto ao CPAP, tem limitações em deformidades faciais, edentados, demência, pois dificultam a adaptação. Metade dos idosos que iniciam o uso abandonam após 1 ano.

▼ Síndrome da apneia obstrutiva de causa central

SAOS na ausência de obstrução ao fluxo aéreo e é mais comum em pacientes com AVC e ICC (Cheyne-Stokes). "Cérebro esquece de respirar temporariamente".

Tratamento devemos otimizar tratamento de ICC, suplementação de O₂, teofilina e BPAP (tipo de VNI).

▼ Roncos

▼ Definição

O enfraquecimento e a perda de tônus da musculatura das vias respiratórias superiores durante o sono predis põem a sua obstrução, havendo uma vibração dos tecidos moles da faringe, localizados entre o palato e a língua, produzindo o ronco.

Acomete mais homens, maior idade.

Causas:

- Relaxamento excessivo por álcool, sedativos, sono muito profundo;
- Excesso de tecido: hipertrofia de adenoides e tonsilas, palato alongado, macroglossia, cistos, tumores de faringe, obesidade;
- Alteração estrutural;
- Infecção de VAS

Associação grande com SAOS, devemos sempre investigar.

▼ Sonolência diurna excessiva

▼ Definição

É a incapacidade de manter-se totalmente desperto ou alerta, pode ser confundido com "fadiga" pelo paciente.

Causas:

- Privação de sono;
- Uso de medicações e substâncias como cafeína, álcool, tabaco;
- Transtornos psiquiátricos e doenças neurológicas;
- SAOS;

- SPI e MPM.

▼ Diagnóstico

É feito por um questionário simples, a Escala de sonolência de Epworth, que basicamente é uma avaliação da probabilidade de o paciente dormir realizando atividades.

■ **TABELA 24.6** Escala de sonolência de Epworth (versão brasileira).

Qual a probabilidade de você cochilar ou dormir, e não apenas se sentir cansado, na(s) situação(ões) que será(ão) apresentada(s) a seguir? (para responder, considere o modo de vida que você tem levado recentemente, mesmo que não tenha feito algumas dessas coisas recentemente, e tente imaginar como elas o afetariam; escolha o número mais apropriado para responder cada questão)

Situações	Chance de cochilar: 0 a 3
Sentado e lendo	
Assistindo à TV	
Sentado, quieto, em um lugar público (p. ex., em um teatro, reunião ou palestra)	
Andando de carro por uma hora sem parar, como passageiro	
Sentado quieto após o almoço sem bebida alcoólica	
Em um carro parado no trânsito por alguns minutos	
Total	

0: nunca cochilaria; 1: pequena probabilidade de cochilar; 2: probabilidade média de cochilar; 3: grande probabilidade de cochilar.

▼ Tratamento

O tratamento da SDE envolve medidas não farmacológicas, em primeiro plano e medidas farmacológicas, quando necessário.

Dentre as medidas não farmacológicas estão a higiene do sono e principalmente fototerapia com luz brilhante.

Medicamentoso é menos utilizado, pode ser utilizado Modafilina.